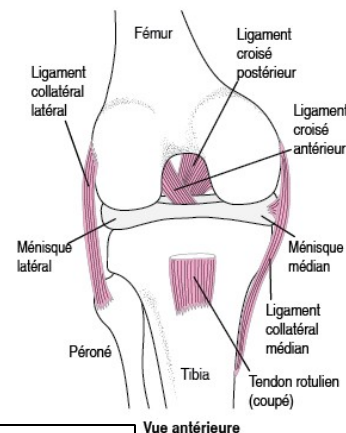


Rappel anatomique :

Pivot central	- LCA freine la translation antérieure - LCP freine la translation post
Plan capsulo-ligamentaire interne	- LLI + PAPI (point d'angle postéro interne) - Freine la rotation externe
Plan capsulo-ligamentaire externe	- LLE + PAPE (point d'angle postéro-externe) - Freine la rotation interne
Coques condyliennes	- Médiales et latérales freinent le recurvatum



Mécanismes :

LLI	- Trauma en valgus
LLE	- Trauma en varus
LCA	- Hyperextension du genou (shoot) et rotation interne : ski - Torsion en valgus-flexion-rotation externe (VALFE) : → Triade interne : LCA + LLI + PAPI → Pentade interne : LCA + LCP + LLI + PAPI + Coques - Torsion en varus-flexion rotation interne (VARFI) : → Triade externe : LCA + LLE + PAPE → Pentade externe : LCA + LCP + LLE + PAPE + Coques
LCP	- Syndrome du tableau de bord : choc direct antéropostérieur → Pentades interne et externe
Luxation	- Toujours secondaire à un traumatisme violent : AVP - Lésions ligamentaires, nerveuses et vasculaires : artériographie en urgence

Signes de gravité :

Signes fct	• Craquement audible, déboitement, impotence totale et immédiate • Choc rotulien : hémarthrose • Laxité frontale
Recurvatum	Rupture des coques condyliennes
Tiroirs	- Tiroir antérieur : test de Lachman : rupture LCA - Tiroir postérieur : rupture du LCP
Ressaut	- Jerk test : pathognomonique du LCA

Paraclinique

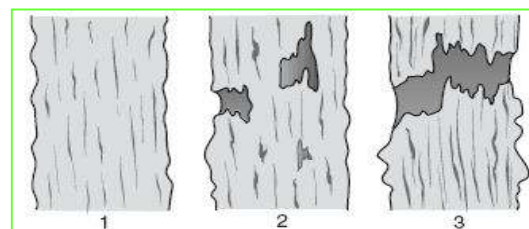
- **Radio** : souvent normales
- **IRM** : Pas d'indication en urgence, Diagnostic positif (hyperT2) et lésions associées (méniscales)
- **Artériographie /Doppler artériel** : en urg si luxation du genou : risque de **lésion de l'artère poplitée 40%**

L'entorse du genou peut intéresser :

1. Le plan méniscal et capsulaire
2. Le plan périphérique : ligamentaire médial ou lig latéral
3. **Le pivot central : LCA ou LCP**

Anapath : 3 degrés de lésions

1. Micro rupture : élongation
2. Rupture sans laxité clinique
3. Vraie rupture avec laxité clinique



- L'entorse bénigne : Atteinte isolée d'1 plan : capsulo-ligamentaire, périph, sans laxité
- L'entorse semi-bénigne : Atteinte d'1 plan périph avec **laxité fronatlé**
- L'entorse grave : Atteinte Pivot central, **laxité rotatoire**

Entorse grave = les triades (4 types)

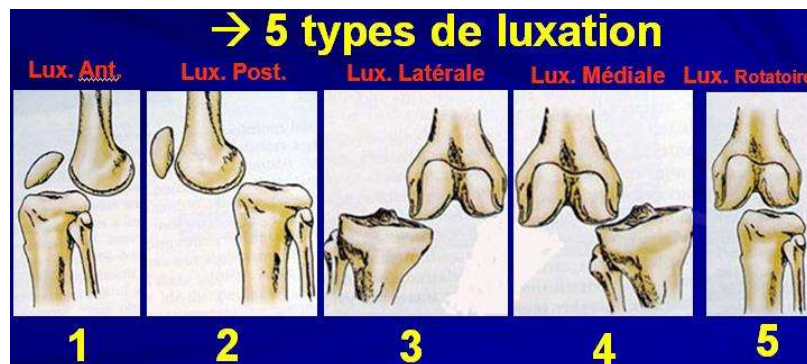
1. LCA + PAPI + LLI = Triade A-I **la + freq**
2. LCP + PAPE + LLE = Triade P-E, rare
3. LCA + PAPE + LLE = Triade A-E, très rare
4. LCP + PAPI + LLI = Triade P-I, très rare, valgus forcé

Pentades : 2 types

1. LCA ++ LCP + PAPI + LLI = Pentade interne
2. LCP ++ LCA + PAPE + LLE = Pentade externe

Luxations du genou : Rupture Pivot central + plan périph. = Pentades : 2 croisés + 2 coques + 1 plan ou de plans entiers latéral et/ou médial

Attention : **Rupture art. poplitée externe = dans 40% des lux. qq soit type**



PEC :

1. **Entorse bénigne** :
 - ✓ attelle, **genouillère (15-21j)** + Trt Médical (glaçon, antalgiques), Rééducation précoce
 - ✓ **Reprise du sport J21-J30**
2. **Entorse semi-bénigne** :
 - ✓ idem, l'immobilisation doit être plus stricte pendant 45 j
 - ✓ **Appui non interdit**
3. **Entorse grave** :
 - ✓ idem, Immobilisation pendant 21 – 45 j, **appui non interdit**
 - ✓ Ligamentoplastie du LCA après 1 – 2 mois du trauma
4. **Les pentades = luxation du genou** :
 - ✓ Réduction en urgence s/ AG + attelle
 - ✓ chirurgie en urgence différée : > 48h : Réinsertion ou plasties pivot et plans périph

